

CAPÍTULO 10.16

Brucelosis, Leptospirosis, Bartonelosis, Fiebre Tifoidea y Fiebre Paratifoidea

PERFIL EUNACOM 1.05.1.016

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Bacteriemias Cíclicas: Fiebre Tifoidea, Brucelosis, Leptospirosis y Bartonelosis

Fiebre Tifoidea

- **Agente:** *Salmonella typhi*. Vía fecal-oral. Reservorio: vesícula biliar humana.
- **Epidemiología en Chile:** Rara. Notificación obligatoria.
- **Clínica:**
 - Fiebre alta (40-41°C) + cefalea
 - **Bradicardia relativa** (pulso lento para la fiebre que tiene)
 - **Roséola tífica** (lesiones eritematosas abdominales)
 - Hepatoesplenomegalia
 - Complicaciones: diarrea febril → hemorragia digestiva o perforación intestinal → sepsis
- **Hemograma tífico:** Leucopenia (no leucocitosis) + desviación izquierda + eosinofilia
- **Diagnóstico:** Hemocultivo (S: 90%) → Gold Standard. Mielocultivo si > 4 semanas. **VDRL de Widal: obsoleto.**
- **Tratamiento:** Ciprofloxacino (elimina también la portación biliar → previene contagio).

Brucelosis

- **Agente:** *Brucella* spp. Zoonosis. Antecedente de contacto con ovejas, cabras, o consumo de queso de cabra.
- **Clínica inespecífica:** Fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia, mialgias. Bacteremia cíclica.
- **Diagnóstico:** Serología (IgM *Brucella*) o hemocultivo.
- **Tratamiento:** Doxiciclina (de elección). Alternativa: Rifampicina.

Leptospirosis

- **Antecedente:** Baño en aguas estancadas o contacto con animales.
- **Clínica clásica (infrecuente pero preguntable):**
 1. **Hepatitis** + ictericia
 2. **Meningitis aséptica** (gram y cultivo negativos; la leptospira no se ve al gram)
 3. **Insuficiencia renal aguda**
 4. **Conjuntivitis** (inflamatoria bilateral o hemorrágica)
- **Diagnóstico:** Serología (IgM *Leptospira*) o microscopía de campo oscuro.
- **Tratamiento:** Penicilina G / Doxiciclina / Ceftriaxona / Azitromicina (fácil de matar).

Bartonelosis (Enfermedad por Arañazo de Gato)

- **Agente:** *Bartonella henselae* (bacilo Gram negativo).
- **Antecedente:** Contacto con gato.
- **Indicación en pediatría:** Causa de fiebre sin foco (pedir IgM *Bartonella* tempranamente).

- **Clínica:** Adenopatías cervicales persistentes + abscesos esplénicos (característico).
- **Diagnóstico:** Serología IgM.
- **Tratamiento:** Azitromicina (macrólido).

Salmonelosis No-Typhi (Ej. *S. enteritidis*, *S. typhimurium*)

- **Vía:** Consumo de alimentos de origen animal contaminados (carne, huevos, lácteos).
- **Clínica:** Diarrea febril autolimitada (intoxicación alimentaria).
- **Tratamiento:** Hidratación ± Ciprofloxacino (no obligatorio en la forma autolimitada).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 30 años con antecedente de haberse bañado en un río hace 10 días consulta por fiebre, ictericia, disminución de diuresis y conjuntivitis hemorrágica bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Brucelosis, Leptospirosis, Bartonelosis, Fiebre Tifoidea y Fiebre Paratifoidea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Brucelosis: zoonosis (ovejas, cabras, queso de cabra), clínica inespecífica, diagnóstico con serología/hemocultivo, tratamiento con doxiciclina.
- Leptospirosis: aguas estancadas/animales. Clínica clásica: hepatitis + ictericia, meningitis aséptica, insuficiencia renal aguda, conjuntivitis hemorrágica. Tratamiento: penicilina/doxiciclina/ceftriaxona/azitromicina.
- Bartonelosis (arañazo de gato): causa de fiebre sin foco en pediatría, adenopatías cervicales persistentes, abscesos esplénicos. Tratamiento: azitromicina.
- Fiebre tifoidea (*S. typhi*): fecal-oral, fiebre alta, bradicardia relativa, roséola tífica, hemograma tífico (leucopenia + desviación izquierda + eosinofilia).
- Diagnóstico de fiebre tifoidea: hemocultivo (elección, >90% sensibilidad). Gold standard: mielocultivo (cuando hemocultivo negativo >4 semanas).
- Tratamiento fiebre tifoidea: ciprofloxacino (elimina portación biliar). Prueba de Widal obsoleta.
- Salmonellas no-typhi: alimentos de origen animal, diarrea febril autolimitada, tratamiento con hidratación.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (BRUCELOSIS, LEPTOSPIROSIS, BARTONELOSIS, FIEBRE TIFOIDEA Y FIEBRE PARATIFOIDEA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 30 años con antecedente de haberse bañado en un río hace 10 días consulta por fiebre, ictericia, disminución de diuresis y conjuntivitis hemorrágica bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Brucelosis
- B) Leptospirosis
- C) Fiebre tifoidea
- D) Hepatitis A
- E) Bartonelosis

PREGUNTA 2

Paciente con fiebre de 3 semanas de evolución, cefalea, bradicardia relativa y diarrea febril. El hemograma muestra leucopenia con desviación izquierda y eosinofilia. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

- A) Coprocultivo
- B) Hemocultivo
- C) Prueba de Widal
- D) Mielocultivo
- E) Serología (IgM) para Salmonella

PREGUNTA 3

Niño de 4 años con fiebre sin foco claro de 2 semanas de evolución. Antecedente de arañazo de gato hace 3 semanas. Al examen presenta adenopatías cervicales. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A) Amoxicilina oral por 10 días
- B) Doxiciclina por 14 días
- C) Azitromicina
- D) Ciprofloxacino por 7 días
- E) Ceftriaxona intramuscular

RESUMEN: BRUCELOSIS, LEPTOSPIROSIS, BARTONELOSIS, FIEBRE TIFOIDEA Y FIEBRE PARATIFOIDEA

Esta clase aborda diversas causas de fiebre por bacteriemias cíclicas y zoonosis. La brucelosis es una zoonosis con clínica inespecífica (fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia) asociada a contacto con ovejas/cabras o consumo de queso de cabra. Se diagnostica con serología o hemocultivo y se trata con doxiciclina. La leptospirosis, otra zoonosis (bañarse en aguas estancadas, contacto con animales), tiene una clínica clásica infrecuente pero preguntable: hepatitis con ictericia, meningitis aséptica, insuficiencia renal aguda y conjuntivitis hemorrágica. Se diagnostica con serología y se trata con penicilina, doxiciclina, ceftriaxona o azitromicina (mismos fármacos que para espiroquetas). La bartonelosis (enfermedad por arañazo de gato, *Bartonella henselae*) es causa de fiebre sin foco en pediatría, con adenopatías cervicales persistentes y abscesos esplénicos. Se trata con azitromicina. La fiebre tifoidea (*Salmonella typhi*, fecal-oral) presenta fiebre alta, cefalea, bradicardia relativa, roséola tífica, hepatoesplenomegalia y diarrea que puede complicarse con hemorragia o perforación. El hemograma tífico muestra leucopenia con desviación izquierda y eosinofilia. El diagnóstico es con hemocultivo (sensibilidad >90%). El tratamiento es ciprofloxacino, que además elimina la portación biliar. La fiebre paratifoidea es similar pero más leve. Las *Salmonellas* no-typhi (*Enteritidis*, *Typhimurium*) producen diarrea febril autolimitada por consumo de alimentos de origen animal.